EHCVM ou RGPH : quel indice de pauvreté multidimensionnelle sert le mieux le Plan National de Développement 2026–2030 de la Côte d'Ivoire ?

Analyse comparative de l'alignement sur les cibles, de la finesse territoriale et de la capacité de suivi

Pipeline PythonIPM

Septembre 2026

RÉSUMÉ.

Deux indices de pauvreté multidimensionnelle (IPM) ont été calculés pour la Côte d'Ivoire sur l'année 2021 : le premier à partir de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM, 12 965 ménages), le second à partir du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 5,6 millions de ménages). Le présent article confronte ces deux sources aux vingt-deux cibles et orientations du Plan National de Développement (PND) 2026–2030 éclairées par un indice de pauvreté, puis tranche dans les deux registres que le plan pose. Les résultats établissent que l'IPM-EHCVM maximise l'alignement de contenu — principalement sur les cibles de santé et de nutrition du Pilier 4, inaccessibles au recensement dépourvu de tout module de santé — et concentrent, à l'inverse, l'opérationnalité sur l'IPM-RGPH, seul à dimensionner les Pôles Économiques Compétitifs du Pilier 5 et le registre social unifié du Pilier 6. Sur la variante harmonisée restreinte aux douze indicateurs communs, les deux dispositifs convergent (M_0 = 0,2737 contre 0,2680, soit un écart de 2 %), ce qui rend leur emploi conjoint opérationnel. La recommandation ne consiste donc pas à choisir une source, mais à répartir les rôles : cadre de résultats porté par l'EHCVM, carte et registre portés par le RGPH, pont de cohérence assuré par la variante harmonisée.

MOTS-CLÉS : pauvreté multidimensionnelle · IPM · EHCVM · RGPH · PND 2026–2030 · Côte d'Ivoire · alignement · ciblage. **CLASSIFICATION JEL :** I32, C80, R28.

---

1 Introduction : deux questions, pas une

Le PND 2026–2030 pose au statisticien deux questions de nature différente, et l'essentiel de la comparaison entre sources tient à ce qu'aucune source ne répond bien aux deux.

1. **Mesurer.** Où en est le pays, et où en sera-t-il en 2030 ? Le plan fixe des cibles chiffrées, pilier par pilier, assorties d'une valeur de départ et d'une valeur d'arrivée. Y répondre exige un indicateur dont le contenu recoupe ces cibles et qui puisse être recalculé en cours de

plan.

2. **Cibler.** Où faut-il investir, et quels ménages faut-il servir ? Le Pilier 5 exige une « cartographie fine » pour ses Pôles Économiques Compétitifs, le Pilier 6 un « registre social unifié », le Pilier 4 une liste de 827 000 ménages. Y répondre exige une base exhaustive, ou à tout le moins une maille territoriale très fine.

Une enquête par sondage est faite pour mesurer : questionnaire long, indicateurs riches, répétée dans le temps. Un recensement est fait pour dénombrer : questionnaire court, indicateurs pauvres, mais exhaustif et localisé. Le plan a besoin des deux ; la comparaison qui suit ne fait que le chiffrer.

2 Données et méthode

2.1 Sources

L'IPM-EHCVM repose sur l'enquête 2021 menée auprès de 12 965 ménages et porte seize indicateurs. L'IPM-RGPH repose sur le recensement 2021, exhaustif, des 5,6 millions de ménages, et porte treize indicateurs. Les deux indices sont produits par le même pipeline de calcul (Pipeline PythonIPM), ce qui garantit l'identité des conventions méthodologiques hors des différences de questionnaire et de nomenclatures.

2.2 Calibration de l'alignement

Vingt-deux cibles et orientations du PND peuvent être éclairées par un indice de pauvreté. Chaque prise a été classée selon six modalités : directe, approchée, indirecte, partielle, opérationnelle (ciblage) et aucune. L'exercice de comparaison territoriale retient la convention usuelle selon laquelle une estimation dont le coefficient de variation (CV) dépasse 20 % n'est pas publiable.

2.3 Variante harmonisée

Le pipeline produit, pour chaque source, une variante restreinte au socle des douze indicateurs communs définis de façon quasi identique. Cette variante constitue la seule comparaison légitime en niveau entre les deux sources, les indices complets n'étant pas directement comparables du fait de la quasi-inertie de la dimension Santé du RGPH.

3 Résultats

3.1 Couverture des cibles du PND

Le décompte brut est résumé au tableau 1 : il attribue à l'EHCVM onze prises directes contre sept au RGPH, auquel s'ajoutent deux prises approchées, deux prises indirectes et trois prises opérationnelles.

Tableau 1. Couverture des cibles et orientations du PND par nature de prise.

Nature de la prise	EHCVM	RGPH
Directe	11	7
Approchée	0	2
Indirecte	3	2
Partielle	2	0
Opérationnelle (ciblage)	0	3
Aucune	6	8

Lecture : vingt-deux cibles et orientations du PND sont classées selon la nature de la prise offerte par chaque source.

Ce décompte flatte l'EHCVM, et il faut savoir pourquoi. D'une part, il compte des cibles : or plusieurs cibles retombent sur le même indicateur — les deux cibles d'analphabétisme sur l'indicateur d'alphabétisation, les deux cibles de couverture sociale sur l'indicateur d'assurance maladie. Rapporté aux indicateurs distincts à prise directe, le compte passe de onze contre sept à neuf contre six. D'autre part, il récompense mécaniquement la source la mieux dotée : l'EHCVM porte seize indicateurs, le RGPH treize. Ce n'est pas un résultat mais une propriété du questionnaire. Ramené à l'essentiel, l'écart réel se concentre sur trois indicateurs : l'assurance maladie, le renoncement aux soins et l'année de scolarité mesurée exactement plutôt qu'approchée par le diplôme. Deux de ces trois indicateurs sont des indicateurs de santé : c'est là, et seulement là, que se joue l'avantage de l'enquête.

3.2 Les cibles que l'une seule source mesure

Le point essentiel se joue sur les onze cibles couvertes par une source et pas par l'autre : sept par la seule EHCVM, quatre par le seul RGPH (tableau 2).

Tableau 2. Cibles et orientations couvertes par une seule source.

Cible ou orientation du PND	EHCVM	RGPH
Enrôlés à la CMU de 20 à 30 millions (P. 4)	oui	non
Protection sociale de 27 à 50 % (P. 4)	oui	non
Population à moins de 5 km d'un centre de santé, 82 à 100 % (P. 4)	oui	non
Retard de croissance des moins de 5 ans, 21,4 à 18 % (P. 4)	oui	non
Désagrégation par sexe du chef de ménage (P. 4)[a]	oui	non
Habitat décent : densité d'occupation (P. 5)	oui	non
Croisement avec la pauvreté monétaire (objectif général)	oui	non
Espérance de vie de 62,3 à 65 ans (P. 4)	non	oui
Pôles économiques compétitifs, villes secondaires (P. 5)	non	oui
Registre social unifié pour le ciblage (P. 6)	non	oui

Cible ou orientation du PND	EHCVM	RGPH
827 000 ménages bénéficiaires des filets sociaux (P. 4)	non	oui

[a] Le sexe est absent de l'extrait RGPH transmis, non du recensement : la numérotation des questions y passe de P16 à P18, la question P17 manquant. Une demande à l'INS lèverait cette limite. Dans les deux sources, désagréger par sexe du chef de ménage éclaire la cible « indice de l'écart genre » sans la mesurer — ce dernier étant un indice composite couvrant l'emploi, l'éducation, la santé et la représentation politique.

LECTURE DES RÉSULTATS

L'EHCVM gagne sur le contenu du Pilier 4 : les cibles de santé et de nutrition sont hors de portée du recensement, qui ne pose aucune question de santé.

Le RGPH gagne sur les instruments des Piliers 5 et 6 : cartographie, registre, ciblage — trois orientations qui ne sont pas des cibles chiffrées mais des dispositifs à construire, et qu'une enquête par sondage ne peut alimenter.

3.3 La finesse territoriale : un écart massif

Le Pilier 5 entend parvenir à « une répartition optimale et équitable des investissements publics et privés » fondée sur une « cartographie fine ». La question se pose donc à la maille à laquelle chaque source produit un chiffre publiable. Le tableau 3 en donne le décompte.

Tableau 3. Mailles de publication par source.

Maille	EHCVM : publiées	EHCVM : non publiées	RGPH : publiées	RGPH : non publiées
Région	33	0	33	0
Département	108	15	111	0
Sous-préfecture ou commune	442	92	519	19

Lecture : une estimation dont le coefficient de variation dépasse 20 % est considérée comme non publiable.

LE CHIFFRE QUI TRANCHE LE PILIER 5

Les 92 sous-préfectures non publiables de l'EHCVM représentent **47,9 % de la population ivoirienne**. Les 19 non publiables du RGPH en représentent **1,55 %**.

Fonder une allocation d'investissements à la maille de la sous-préfecture sur l'EHCVM reviendrait donc à ne rien pouvoir dire, de façon publiable, sur la moitié du pays. Le recensement ramène cette zone d'ombre à un cinquantième.

Le coefficient de variation médian donne la même lecture en continu : 15,4 % contre 9,0 % à la sous-préfecture, et 12,3 % contre 5,0 % au département.

3.4 Le suivi dans le temps : un écart tout aussi massif, en sens inverse

Le recensement est décennal : le prochain RGPH n'interviendra pas avant la fin du plan. L'IPM-RGPH fournit donc une valeur de départ très détaillée, mais aucune évolution — ce point est certain. Dans un plan quinquennal assorti de cibles datées, un indice que l'on ne peut recalculer qu'une fois n'est pas un indicateur de suivi : c'est un argument qui ne se compense pas.

L'EHCVM est en revanche une enquête répétée — 2018, puis 2021. Le rythme passé laisse attendre une vague dans l'intervalle du plan, mais aucune programmation n'a été vérifiée ici. L'argument « seule l'EHCVM permettra le suivi » suppose cette vague et doit être confirmé auprès de l'INS avant d'être avancé devant une instance de décision.

3.5 Ce que les deux mesurent également bien

Douze indicateurs sont communs aux deux sources ; pour sept d'entre eux, la définition est quasi identique et les taux de privation se suivent de près, ce qui valide les deux calculs l'un par l'autre (tableau 4).

Tableau 4. Taux de privation des indicateurs communs.

Indicateur	EHCVM	RGPH	Commentaire
Année de scolarité	62,9 %	63,2 %	le diplôme approche bien les années d'études
Énergie de cuisson	66,3 %	62,7 %	—
Emploi de subsistance	40,5 %	46,0 %	approximation côté RGPH
Fréquentation scolaire	31,9 %	35,6 %	—
Biens d'équipement	21,7 %	18,2 %	le RGPH mesure les 8 biens, l'EHCVM 7
Logement	17,3 %	25,0 %	nomenclatures de matériaux différentes
Électricité	9,3 %	11,5 %	—
Chômage	6,5 %	5,9 %	—
Eau potable	20,9 %	14,3 %	le RGPH perd le temps de trajet
Toilette	67,2 %	45,1 %	le RGPH perd le partage des sanitaires
Alphabétisation	62,9 %	70,4 %	—
État civil	26,3 %	15,2 %	—

3.6 Le test de cohérence : la variante harmonisée

Le pipeline produit, pour chaque source, une variante restreinte au socle des douze indicateurs communs — la seule comparaison légitime entre les deux. Les indices concordent (tableau 5).

Tableau 5. Variante harmonisée (socle commun de douze indicateurs).

Source	H (incidence)	A (intensité)	M_0

Source	H (incidence)	A (intensité)	M_0
EHCVM 2021	53,5 %	0,5113	**0,2737**
RGPH 2021	52,0 %	0,5157	**0,2680**

Un résultat qui compte pour le PND

À indicateurs identiques, une enquête par sondage et un recensement exhaustif, collectés la même année par deux dispositifs entièrement différents, donnent **un écart de 2 %** sur l'indice M_0.

Conséquence pratique : la carte territoriale du recensement et le tableau de bord de l'enquête peuvent être utilisés ensemble sans craindre qu'ils racontent deux histoires différentes. C'est ce qui rend l'architecture recommandée ci-dessous opérationnelle, et non seulement théorique.

4 Discussion et verdict

4.1 Lequel est le plus aligné ?

L'IPM-EHCVM, pour trois raisons qui se cumulent. Premièrement, il couvre le cœur du Pilier 4 — le pilier du capital humain — où se concentrent les cibles sociales du plan : les cibles de santé et de nutrition (CMU, protection sociale, accès aux soins) sont hors de portée du recensement, qui ne pose aucune question de santé. C'est l'argument principal, et le seul qui soit hors de discussion. Deuxièmement, il porte la consommation, donc permet de croiser pauvreté monétaire et multidimensionnelle — exactement ce qu'appelle l'objectif général du plan et ce que le recensement ne permet pas. Troisièmement, il est actualisable en principe, étant une enquête répétée, là où le recensement décennal ne le sera pas avant 2031 ; le calendrier précis de la prochaine vague reste à confirmer.

Un quatrième argument est souvent avancé — « il couvre onze cibles contre sept » — mais il ne résiste pas à l'examen : rapporté aux indicateurs distincts, l'écart est de neuf contre six et se réduit aux trois indicateurs cités en section 3.1. La conclusion ne repose donc pas sur ce décompte, mais sur l'absence de module de santé au recensement, qui est un fait.

4.2 Lequel aide le mieux ?

Cela dépend de ce qu'on appelle aider : la réponse honnête est que les deux sources aident à deux moments différents du cycle de la politique publique (tableau 6).

Tableau 6. Répartition fonctionnelle des sources selon le moment du cycle de politique publique.

Moment	Ce que le PND demande	Source
Cadrer	fixer la cible de pauvreté à 2030, que le plan a laissée en blanc	EHCVM

Moment	Ce que le PND demande	Source
Répartir	allouer les investissements du Pilier 5 entre territoires	RGPH
Cibler	constituer le registre social unifié, servir 827 000 ménages	RGPH
Suivre	mesurer les progrès à mi-parcours et en 2030	EHCVM
Rendre compte	documenter l'atteinte des cibles du cadre de résultats	EHCVM

CE QUE CHOISIR UNE SEULE SOURCE COÛTERAIT

Ne garder que l'EHCVM : le Pilier 5 perdrait sa base statistique — près de la moitié de la population relèverait d'une zone dont l'IPM n'est pas publiable — et le registre social unifié du Pilier 6 devrait être construit sans information de privation.

Ne garder que le RGPH : le plan perdrait toute mesure de la santé, de la nutrition, de la protection sociale et du genre — c'est-à-dire la plus grande partie des cibles sociales du Pilier 4 — et n'aurait aucun moyen de constater ses progrès avant 2031.

5 Conclusion : une architecture recommandée à trois pôles

La recommandation n'est pas de choisir une source, mais de répartir les rôles.

5.1 Les trois rôles

1. **L'EHCVM tient le cadre de résultats.** M_0 = 0,2863 en 2021 devient la valeur de départ ; une cible 2030 est fixée, comblant la seule absence de valeur chiffrée parmi les objectifs majeurs du plan ; onze cibles sectorielles sont suivies sur une série unique et cohérente, plutôt que sur onze statistiques éparses.
2. **Le RGPH tient la carte et le registre.** Un IPM publiable pour 111 départements et environ 500 sous-préfectures fonde la planification spatiale du Pilier 5. Les 5,6 millions de ménages — dont 1 751 746 pauvres et 285 115 en pauvreté sévère — chacun avec son score et sa localisation, fondent le registre social du Pilier 6 et le ciblage des filets sociaux.
3. **La variante harmonisée fait le pont.** Elle garantit que les deux instruments parlent de la même chose et sert de contrôle : si un futur IPM-EHCVM s'écartait fortement de la trajectoire attendue, la comparaison harmonisée dirait s'il s'agit d'un effet réel ou d'un artefact de mesure.

5.2 Ce qu'il reste à faire

1. Faire adopter une cible d'IPM à 2030 dans le cadre de gouvernance du PND — la seule action qui transforme un travail statistique en instrument de pilotage.
2. Publier la carte RGPH à la maille du département et de la sous-préfecture, en signalant les 19 sous-préfectures non publiables.

3. Arbitrer les deux points méthodologiques ouverts avant toute publication : le taux de privation de la toilette au RGPH, non réconcilié avec la production Stata antérieure, et l'approximation de l'emploi agricole de subsistance, qui porte à elle seule 26,8 % de l'indice RGPH.
4. Reprendre le croisement monétaire / multidimensionnel sur la méthode officielle de calcul du taux de pauvreté, pour documenter l'objectif général du plan.
5. Prévoir le recalcul de l'IPM-EHCVM sur la prochaine vague d'enquête, aux mêmes définitions — le pipeline le permet sans modification.

6 Limites de la comparaison

1. Le décompte des cibles est un jugement, pas une mesure, et il est biaisé en faveur de la source la mieux dotée en indicateurs. Classer une prise en « directe », « approchée » ou « indirecte » suppose d'apprécier la proximité entre un indicateur de ménage et une cible souvent formulée en taux individuel. C'est pourquoi la conclusion repose non sur ce décompte, mais sur l'absence de module de santé au recensement — un fait.
2. Le PND ne contient aucune cible d'IPM : l'alignement établi ici est un alignement de contenu. Rien dans le plan n'engage à retenir cet indice.
3. Les deux IPM complets ne sont pas comparables en niveau, la dimension Santé du RGPH étant presque inerte : toutes les comparaisons de niveau passent par la variante harmonisée.
4. Les cibles du PND portent des années de référence hétérogènes (2021, 2023, 2024, 2025) alors que les deux IPM sont datés de 2021. Les écarts à la cible ne sont donc pas des écarts à une valeur de départ officielle.

Références

Pipeline PythonIPM (2026). *EHCVM ou RGPH : quel IPM sert le mieux le PND 2026–2030 ? Analyse comparative et recommandation.* Note de recherche, documentation du pipeline.

Pipeline PythonIPM (2026). *Alignement PND — IPM EHCVM* ; *Alignement PND — IPM RGPH.* Analyses préalables, documentation du pipeline.

Les comptes détaillés des indicateurs et des cibles renvoient aux deux documents d'analyse précités, dont le présent article suppose connus les constats tout en pouvant se lire de façon autonome.